

URGENCIAS EN PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Carmen Manso, Cristina Forcelledo

La atención al paciente infanto-juvenil con carácter de urgencias se ha convertido en los últimos años en una práctica psiquiátrica cada vez más frecuente.

Los motivos para acudir a la urgencia son muy variados, desde crisis de violencia y agresividad, cuadros psicóticos, consumo de sustancias, crisis de ansiedad, intentos de suicidio, hasta problemas familiares, trastornos de conducta, actos delictivos...

El primer objetivo de la urgencia es garantizar la seguridad del paciente, después hacer una rápida evaluación de los motivos de consulta y el cuadro clínico, poner en marcha las medidas terapéuticas inmediatas, pedir exploraciones complementarias si precisan, emitir un diagnóstico y decidir si es necesario un ingreso o no y establecer un tratamiento y hacia donde derivarlo al alta.

Todo esto basado en la historia clínica, información de los padres o cuidadores, informes previos, y otras fuentes de información.

Epidemiología: alrededor de un 5% de las urgencias pediátricas se corresponden con urgencias psiquiátricas infanto-juveniles. Los menores que más frecuentemente consultan son adolescentes (entre 11-15 años) y con ligero predominio en el sexo femenino (52%); los motivos de consulta más frecuentes son: Trastorno de Conducta (37%); Trastorno de Ansiedad Generalizada (21%) e ideación autolítica (13%).

EVALUACIÓN CLÍNICA EN PSIQUIATRÍA INFANTIL:

Lo primero que debemos intentar es establecer una buena relación terapéutica. El derecho a la confidencialidad en adolescentes existe y debemos establecer este marco legal y de confianza al inicio de la entrevista puesto que resulta de vital importancia y es percibida como la base de la confianza.

Debemos intentar una alianza terapéutica con todos los implicados (paciente, familiares, colegio...) y es necesario entrevistar al joven solo y a continuación a los familiares.

- **MOTIVO DE CONSULTA:** imprescindible. Conviene hablar por separado con el menor y los padres/cuidadores y establecer contacto telefónico si hace falta. Si el paciente acude sin sus padres conviene llamarlos lo antes posible.
- **ANTECEDENTES PERSONALES:** tanto somáticos como psiquiátricos/psicológicos. Tratamientos previos y actuales.
- **PSICODESARROLLO:** un breve resumen de los principales hitos del desarrollo: embarazo y parto, desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje; nivel de lenguaje actual, control de esfínteres, alteraciones del movimiento, así como nivel de estudios, rendimiento escolar y comportamiento en el mismo. Importante recoger el nivel de funcionamiento previo y actual.
- **HISTORIA FAMILIAR:** con quien vive, relaciones familiares, tipo de convivencia, así como antecedentes familiares relevantes (somáticos y psiquiátricos).
- **ENFERMEDAD ACTUAL Y FACTOR DESENCADENANTE:** debemos identificar los síntomas principales y además aquellos que acarrearán mayor sufrir más al menor y aquellos otros que perturban la convivencia. Estos síntomas serán las dianas de intervención.
- **EXPLORACIÓN FÍSICA** para descartar otros procesos patológicos.
- **EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA:** debe de ser completa siempre que se pueda; otras

veces por las circunstancias, estará focalizada en los síntomas, pero siempre debemos incluir signos de ansiedad, ideación auto/heterolítica, alteraciones de la esfera psicótica y orientación.

- Apariencia y aspecto físico.
 - Relaciones con el entrevistador y el entorno.
 - Orientación.
 - Estado atencional.
 - Impulsividad y tolerancia a la frustración.
 - Humor y afectividad.
 - Signos de ansiedad psíquica y física.
 - Auto/heteroagresividad.
 - Alteración del curso/contenido del pensamiento.
 - Lenguaje y alteraciones del discurso.
 - Alteraciones sensorio-perceptivas.
 - Psicomotricidad.
 - Rasgos de personalidad.
 - Capacidad de juicio y planes de futuro.
 - Sueño y apetito.
- **EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:** analítica completa, tóxicos, ECG, EEG (si se sospecha epilepsia), técnicas de imagen, sobre todo si no existen antecedentes personales psiquiátricos.
 - **DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:** suelen ser diagnósticos longitudinales, por lo que muchas veces no es posible realizarlo en una situación de urgencias. Aquí el diagnóstico tendrá valor orientativo o preliminar y haremos énfasis en el cuadro clínico del paciente en ese momento y en los síntomas más graves.
 - **PLAN TERAPÉUTICO:** lo primero que debemos hacer es tranquilizar al paciente y a la familia y establecer las medidas de seguridad en caso de riesgo de actos violentos, agitación, peligro de huida o intentos de suicidio. Finalmente estableceremos un tratamiento farmacológico para determinados síntomas como ansiedad, agresividad o agitación.
 - Como estrategia final y para evitar la angustia familiar o vuelta al servicio de urgencias debemos informar claramente del diagnóstico y pautas de manejo en domicilio.

No debemos olvidar que los niños y adolescentes son seres en desarrollo siendo extremadamente influenciados del ambiente que les rodea.

Así se recomienda no solo un enfoque clínico (factores biológicos, psicológicos y sociales del paciente) sino también el sistema familiar que le rodea y de su entorno social y comunitario.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

El objetivo principal es la seguridad y proteger tanto al paciente como a terceros, por lo que la evaluación y el manejo del riesgo asociado a la clínica psiquiátrica es un componente esencial en nuestra actuación en urgencias.

Las áreas de exploración son:

- Vulnerabilidad: exposición a experiencias peligrosas a través de factores personales o ambientales.
- Conductas o ideas suicidas.
- Inestabilidad psicopatológica.

- Agresión a terceros.

En la atención en urgencias se debe implicar a la familia tanto en la recogida de información como a la hora de elaborar un plan de seguridad para predecir nuevos actos de riesgo.

A continuación, se explicarán los principales cuadros que podemos encontrar en el servicio de urgencias psiquiátricas en edad infanto-juvenil: paciente agitado; intentos/ideas de suicidio y trastorno de ansiedad.

PACIENTE AGITADO

Numerosos trastornos psiquiátricos, circunstancias y enfermedades pueden motivar la agitación de un menor:

- Trastornos con impulsividad: **trastorno negativista desafiante**, TDAH, **trastorno de conducta**, trastorno bipolar, **intentos de suicidio**, rasgos de personalidad intensos.
- **Cuadros psicóticos**: la agitación psicomotriz y agresividad puede darse tanto en la esquizofrenia de inicio temprano como en la adolescencia, pudiendo formar parte de un primer episodio psicótico o como una recaída.

En los adolescentes predominan las paranoias, la ansiedad, la agitación, descontrol, obsesividad e ideación suicida.

En un primer episodio psicótico debe descartarse la organicidad.

- Consumo y dependencia de drogas.
- Trastorno general del desarrollo y retraso mental que favorecen las reacciones agresivas ante situaciones frustrantes, siendo muy frecuentes las agitaciones.
- Los Trastornos del Espectro Autista son muy sensibles a cambios de rutina o ambientes y a enfermedades que sufren y que no se diagnostican debido a su dificultad comunicativa.
- Medio familiar caótico y desorganizado, con violencia, privación y maltrato.
- Trastorno de estrés post-traumático.
- Enfermedades orgánicas y estados patológicos de tipo metabolopatías, infecciones, encefalopatías, ingestiones medicamentosas y efectos adversos de fármacos.
- Enfermedades neurológicas (sobre todo epilepsia temporal y crisis parciales), TCE.

Manual de actuación ante un menor agitado:

Actuar con prontitud.

Medidas de protección para el paciente que sean terapéuticas.

Mantener la calma y poner en marcha las medidas de seguridad más urgentes.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN ANTE EL PACIENTE AGITADO

Se deben realizar en medio seguro; con el número suficiente de personas adiestradas.

Los pacientes activamente agitados no responden a intervenciones verbales que pueden incluso aumentar la agitación, por lo que está indicada la contención física y la sedación farmacológica.

Las medidas de intervención se han dividido en:

- Medidas ambientales: sobre todo en los pródromos. Separar al paciente de la causa que ha

generado la agresividad (novia, padres, hermanos...); buscar un lugar tranquilo y sin objetos potencialmente peligrosos al alcance del paciente, respetar la privacidad e intimidad del paciente en la medida de lo posible sin asumir riesgos innecesarios.

- Contención verbal: en niños y adolescentes debería ser la primera medida si se puede. Están encaminadas a que el paciente se tranquilice mediante técnicas verbales y de comunicación: iniciar la entrevista por aspectos diferentes a la violencia, buscando incluso temas en común; actitud empática y mostrar interés; no humillar ni hacerle sentir rechazado; ceder a peticiones razonables; procurar una descarga emocional controlada permitiendo que el menor hable de lo que ha ocurrido. Finalmente llegamos a la fase de sugestión induciendo sentimientos de tranquilidad en el paciente (“después de hablarlo te encontrarás más tranquilo”; “tenías que descargar” ...). todo esto solo es posible si el paciente no tiene una actitud hostil o desconfiada hacia nosotros. Finalmente debería haber una fase de clarificación en la que se hiciese un breve resumen afín de ayudarlo a separar realidad objetiva del concepto subjetivo distorsionado que tiene de esa realidad.
- Contención física: solo debe usarse cuando sea necesaria para proteger al paciente y otras personas. En este caso antes de hacerla se debería informar a los padres o tutores legales a los que se les dejará fuera.
- Tratamiento farmacológico: la mayoría de las veces tenemos que recurrir a la vía intramuscular, pero en menores hay que ofrecerles medicación oral antes; si la aceptan se recomienda: Risperdal (2-10mg), Olanzapina (entre 2,5-20mg) y ahora empieza a probarse el aripiprazol IM. Si no acepta la vía oral, el fármaco más usado es el haloperidol: dosis en niños a partir de 3 años: 2,5mg IM (1/2 ampolla) y en adolescentes 5mg (1 ampolla).

INTENTOS DE SUICIDIO

Cada vez más frecuentes. El comportamiento suicida aumenta en la adolescencia, sobre todo en las mujeres.

El intento y la ideación suicida surgen la mayoría de las veces en el contexto de problemas y conflictos familiares crónicos (separación, abandono, maltrato...).

El niño se siente solo, desconcertado, sin nadie con quien hablar, triste y deprimido y piensa que la muerte es el único remedio. El intento es siempre el medio de salir de una situación insoportable y pasar a otra mejor.

Señales de alerta: ánimo deprimido, sentimientos de soledad y desvalimiento, pensamientos y preocupación acerca de la muerte y deseo de morir, los antecedentes personales de depresión y conductas suicidas. El primer factor de riesgo es la existencia de un suicidio consumado en un familiar de primer grado.

Durante nuestra evaluación debemos transmitir seguridad y confianza, dejar clara la gravedad de la conducta y evaluar las características del intento y su potencial lesivo. En el informe clínico debemos recoger los siguientes aspectos:

- Método utilizado.
- Accesibilidad a los agentes utilizados.
- Nivel de planificación (premeditado/impulsivo).
- Intencionalidad (muerte, aliviar malestar, herir a terceros, demanda de ayuda).
- Probabilidad de rescate.
- Notas de suicidio u otros medios de comunicación del acto.
- Perspectiva del joven acerca del potencial de letalidad.

- Crítica del acto.
- Intentos previos.
- Proyección de futuro.

La decisión final de ingresar al paciente dependerá de la letalidad del intento, de la exploración psicopatológica y persistencia de las ideas de suicidio, de la patología psiquiátrica asociada y de la incapacidad de la familia de contención.

BIBLIOGRAFÍA

- San Sebastián J, Quintero FJ. Urgencias en psiquiatría infantojuvenil. En: Chinchilla A, Correas J, Quintero FJ, Vega J, editores. Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson; 2003. p. 393-400.
- Alda JA, Gabaldón S. Urgencias Psiquiátricas. En: Soutullo C, Mardomingo MJ, Manual de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. 1a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010. p. 381-394.
- Basant K. Puri; Ian H. Treasaden; Urgencias de psiquiatría. Serie Manuales. Biblioteca Aula médica.
- M.J. Mardomingo. Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente. Ediciones Díaz de santos; 2015 Capítulo 27 (p 1005-10017); Capítulo 32: Urgencias psiquiátricas de niños y adolescentes (p 1147-1164)
- L. Villalta; Diagnóstico de urgencias y el informe urgente. Módulo urgencia psiquiátrica infantil y del adolescente. Máster propio en psiquiatría infantil y juvenil, Universidad Cardenal Herrera.
- Sthall.